

伤寒论条文解读

条文卡片合集 PDF

条文数量

10 条

资料定位

中医条文学习资料

本次包含

1-10条

说明：本资料内容为学习胡希恕和李冠杰老师体系心得，如有表述欠妥处，与李冠杰老师无关，是作者学习和领会不足所致。更全面的体系知识推荐大家学习胡希恕老师和李冠杰老师的《康平本伤寒论讲稿》和《金匱要略讲稿》。**声明：**以下内容仅是学习资料整理，不构成任何医学建议。



第1条

1 太阳之为病，脉浮，头项强痛而恶寒。

词语解析

- **太阳病**：不是某一个固定病名，而是凡见**脉浮、头项强痛、恶寒**这一组表证反应，都可归入太阳病范围。
- **脉浮**：潜在动脉高度**充血**，血中**水分增多**
- **头项强痛**：太阳病时人体为了从体表排邪，大量体液和血液趋向体表，形成浅表充血，而且**越往上部越明显**
- **恶寒**：体表温度升高，**空气温差骤然变大**，会感觉外面空气很冷

要点总结

- 第1条是**太阳病总纲**。
- 核心证候：**脉浮、头项强痛、恶寒**。
- 病理抓手：**病在表，正气趋表，欲汗不得汗**。

胡希恕讲解

胡希恕老师讲太阳病，重点不把它看成某个固定病名，而看成**人体在表的一种抗病反应**。外邪来时，机体先**把抗病力量调到体表，血液、水分也趋向体表**，所以见脉浮。
头项强痛，**上半身、头项部充血较重**；恶寒，体表温度升高，与外界**温差增大**。
胡老也常提醒，太阳病只是总纲，具体治疗还要继续分中风、伤寒、温病，以及有汗无汗、发热轻重、脉缓脉紧等，不可见太阳病三字就固定用一个方。

李冠杰讲解

李冠杰老师把第1条视为**太阳病总纲**，它**不是讲现代医学某一个病**，而是给后面所有太阳病条文定范围。
这一条最重要的三个抓手是**脉浮、头项强痛、恶寒**。
学习时要把第1条和第2、第3条连起来看：第1条定太阳病范围，第2条分出中风，第3条分出伤寒，后面桂枝汤、麻黄汤等方证都从这里展开。



第2条

① 太阳病，**发热汗出恶风，脉缓者**，名为**中风**。

词语解析

- **中风**：这里的中风不是卒中，而是太阳病中的一类表虚证，核心是**发热、汗出、恶风、脉缓**。
- **汗出**：**不是大汗出，而是潮乎乎的汗**，出了汗，但达不到驱逐疾病的效果
- **恶风**：汗后体表疏松、湿润，风一吹，散热加快，因此格外怕风
- **脉缓**：缓和紧相对（用烟卷类比，**烟多则紧，烟少则缓**），脉缓的原因是，汗出了**水分丧失了一部分**

要点总结

第2条提出太阳中风。

辨证核心：**发热、汗出、恶风、脉缓**。

与伤寒区别：**中风偏表虚有汗，伤寒偏表实无汗**。

恶寒：没有风吹也怕冷；恶风：风吹怕冷加重

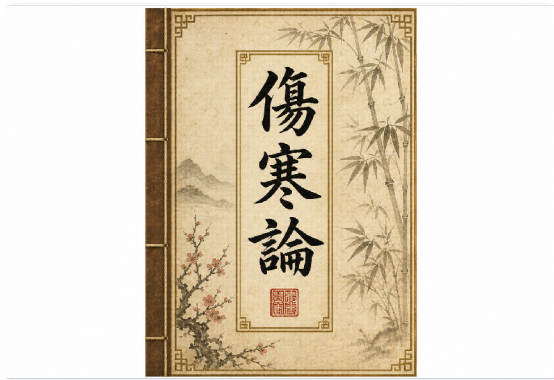
胡希恕讲解

胡希恕老师讲中风，不是现代所谓脑卒中，而是太阳病里**表虚有汗**的一类。发热和汗出并见，说明人体已经有向外排邪的趋势，但卫外不固，汗出而表仍不解；

这一条为后面的桂枝汤证作铺垫。胡老辨桂枝汤，不是单看发热，而是看**汗出、恶风、脉缓弱、表虚营卫不和**这一组反应。

李冠杰讲解

李冠杰老师讲这里的“中风”不能望文生义成脑血管病，而要回到条文本身。本条重点是**发热、汗出、恶风、脉缓**。它和第3条伤寒正好相对：中风有汗、脉缓，伤寒多无汗、体痛、脉紧。本条就是太阳中风的主干，后面第12、13条桂枝汤证是对它的展开。



第3条

1 太阳病，或已发热，或未发热，必恶寒，体痛，呕逆，脉阴阳俱紧者，名曰伤寒。

词语解析

- 伤寒：指表实证。核心是恶寒重、体痛、呕逆、脉紧。
- 或已发热，或未发热：发热可已出现，也可暂未出现，但恶寒是太阳伤寒的标志症状。
- 体痛：大量体液、血液被输送到体表，微细血管高度充盈，压迫身体组织和神经，于是出现体痛。
- 呕逆：全身毛孔闭塞后，气不得向外疏散，便循消化道上逆，形成想吐、呕逆
- 脉阴阳俱紧：体液、血液把血管充得饱满，按下去就显得紧而有力

要点总结

第3条提出太阳伤寒。

发热可有可无，但恶寒是必见的

核心抓手：必恶寒、体痛、呕逆、脉阴阳俱紧。

与第2条区别：第2条偏汗出脉缓，第3条偏无汗脉紧。

胡希恕讲解

胡希恕老师讲太阳伤寒，核心是表实无汗、寒束于表。发热可有可无，但恶寒是必见的，因为表闭未开，正邪相争在表。

体痛说明表闭较重，经脉、肌肉气血不利；呕逆是表证较重时影响胃气上逆；脉阴阳俱紧，则是寒邪束表、津液不得外达的脉象。

胡老会把本条和第2条对读：第2条是桂枝汤方向，第3条是麻黄汤方向。临床不能只看“太阳病”，还要看有汗无汗、脉缓脉紧、身痛轻重。

李冠杰讲解

李冠杰老师讲原文用“或已发热，或未发热”提醒我们，发热不是最硬的判断点。真正必须抓住的是必恶寒、体痛、呕逆、脉阴阳俱紧。尤其“必恶寒”说明只要表证未解，恶寒就很关键。

“伤寒”只是这组症状反应的名称，不是说患者一定受到外界寒邪侵袭，也不是某条经络发生病变。

第3条界定的是太阳伤寒证型，还不能直接与麻黄汤方证完全画等号；具体使用麻黄汤，还要继续结合第35条的无汗、身疼腰痛、骨节疼痛、喘等完整方证。病人不会完全按照书本上的固定症状组合发病，仍须综合判断。



第4条

3 伤寒一日，太阳受之，脉若静者，为不传；颇欲吐，若躁烦，脉数急者，为传也。

词语解析

- 一日太阳受之：传与不传，唯一标准是**症状反应**
- 脉若静：脉不特别大、不特别快，病势相对平静，提示**病轻，暂不向内发展**。
- 颇欲吐：不是微微恶心，而是**很想吐**，提示有向少阳柴胡证方向发展的趋势。
- 躁烦、脉数急：烦躁、脉快而急，说明病势在进展，要警惕**传变风险**。

要点总结

第4条讨论伤寒初起的传与不传，唯一标准是**症状反应**。

不传抓手：**脉若静**。

欲传抓手：**颇欲吐、躁烦、脉数急**。

胡希恕讲解

胡希恕老师讲传与不传，不主张死按一日太阳、二日阳明、三日少阳这样的机械传经。关键仍是**观察脉证变化**。

脉若静，说明病势平稳，暂时没有向内发展的证据；如果出现颇欲吐、躁烦、脉数急，说明病势活动起来，可能转向少阳、阳明或其它阶段。

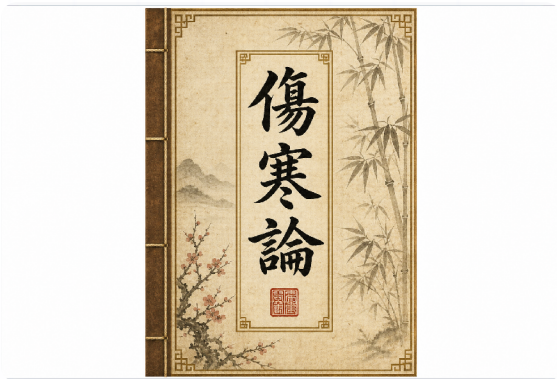
胡老的思路是：**不要用日期决定治疗，而要看当前有没有新的方证**。传不传，不在日数，而在欲吐、躁烦、脉数急等**实际证候**。

李冠杰讲解

李冠杰老师指出不是太阳病主纲，而是对伤寒初起病势变化的说明。

本条最有用的是把“静”和“动”分开看：**脉若静者，为不传**，是病势暂平；**颇欲吐、躁烦、脉数急**，是向内或向其它证转化的苗头。

学习时不要把“伤寒一日，太阳受之”读成固定流程。李冠杰更强调：这是给临床观察病势的一个方法，**仍然要以证候为准**。



第5条

3 伤寒二三日，阳明、少阳证不见者，为不传也。

词语解析

- 二三日：只是观察病势变化的时间窗口，不可按日数机械判定传经。
- 阳明证不见：未见里热、口渴汗出、胃家实、腹满便硬等阳明方向证据。
- 少阳证不见：未见往来寒热、胸胁苦满、心烦喜呕、口苦咽干等少阳方向证据。
- 为不传：没有新证据就不能预设传变，仍应按现有脉证辨治。

要点总结

- 第5条承接第4条，继续判断传与不传。
- 核心标准：阳明、少阳证不见者，为不传也。
- 临床原则：按现有脉证辨治，不按日数预设传变。

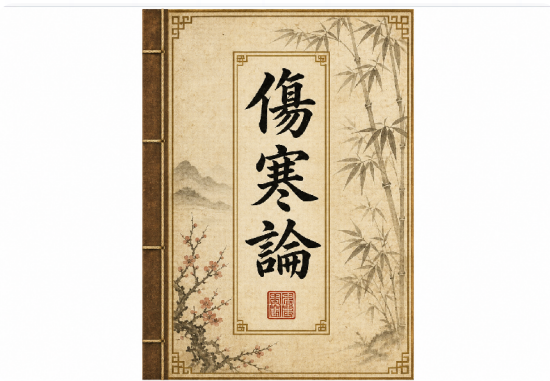
胡希恕讲解

胡希恕老师讲第5条，仍是反对机械传经。二三日只是病程中的观察点，不能说到了二三日就一定传阳明、少阳。
真正要看的，是有没有阳明里热、胃家实、少阳半表半里这些具体表现。若阳明、少阳证不见，就说明病势没有向这些方向发展。
所以本条的临床精神是：不要用日期决定治疗，要用当前证候决定治疗。传不传，不在日数，而在证据。

李冠杰讲解

李冠杰老师讲第5条为降两字格，标三级。它承接第4条，继续说明传与不传不是按日期硬算。
“阳明、少阳证不见”是本条主眼：没有口渴汗出、胃家实、往来寒热、胸胁苦满、喜呕等证据，就不能说已经传入阳明或少阳。
学习时要抓住一句话：见证才算，不见证不算。这是防止套六经流程的关键。

第6条



- 1 太阳病，发热而渴，不恶寒者，为温病。
- 2 若发汗已，身灼热者，名风温。
- 1 风温为病，脉阴阳俱浮，自汗出，身重，多眠睡，鼻息必鼾，语言难出。
- 2 若被下者，小便不利，直视失溲；若被火者，微发黄色，剧则如惊痫，时瘈瘲；若火熏之，一逆尚引日，再逆促命期。

词语解析

- 温病：温病不属于太阳病，与太阳病的明显区别：“不恶寒，渴”
- 发热而渴：渴是内热的表现，像阳明病白虎汤证也是
- 风温：温病误汗后热势更盛，见身灼热、自汗出，说明汗法伤津助热。
- 自汗出、身重、多眠睡：热盛津伤、正气受困，出现身重嗜睡、鼻鼾、语言难出等重象。
- 误下误火：温热病误下、误火，可见小便不利、直视失溲、发黄、惊痫、瘈瘲，为危重变证。
- 不恶寒：里热太甚，大过温差带来的恶寒感，所以不怕冷

要点总结

- 第6条要分段看：温病、风温、风温为病、误治变证。
- 温病抓手：发热而渴，不恶寒。
- 治疗边界：不可按太阳伤寒、中风随便发汗。
- 误治风险：汗、下、火法皆可促成危候。

胡希恕讲解

胡希恕老师讲第6条，重点是把温病、风温同普通太阳中风、伤寒分开。它虽然写“太阳病”，但抓手是发热而渴，不恶寒，说明病性偏温热，津液已受影响。若误发汗，热势更盛，出现身灼热、自汗出、身重、多眠睡、鼻鼾、语言难出，这已不是一般表证。后半反复讲误下、误火、火熏的危害，是提醒医者：温热病不可误用汗、下、火法，必须先辨病性，再定治法。

李冠杰讲解

李冠杰老师特别注意第6条的康平本排版：本条内部有顶格、降一字格，卡片中应分段看等级，而不是把长条文一概当成同一层。第一段以发热而渴，不恶寒定温病主眼；第二段讲误汗后身灼热为风温；第三段列风温重证；第四段讲误治危候。学习本条最重要的是：温病不是太阳伤寒、中风，误汗误下误火都可能加重。



第7条

3 病有**发热恶寒者，发于阳也；无热恶寒者，发于阴也**。发于阳者，七日愈；发于阴者，六日愈；以阳数七、阴数六故也。

词语解析

- **发热恶寒**：发热与恶寒并见，说明正气抗邪较有力，多从**阳性表证**方向理解。
- **无热恶寒**：只恶寒而不发热，提示机能沉衰、阳气不足，要警惕**阴证、少阴或里虚寒**。
- **发于阳、发于阴**：不是固定病名，而是根据**发热有无和整体机能状态**判断阴阳属性。
- **七日、六日愈**：属于古人病程与术数解释，临床可参考，**不能代替辨证**。

要点总结

- 第7条区分**发于阳、发于阴**。
- 阳性抓手：**发热恶寒**。
- 阴性抓手：**无热恶寒**。
- 六七日只是病程参考，**不能替代脉证辨证**。

胡希恕讲解

胡希恕老师讲第7条，会把重点放在阴阳属性上。**发热恶寒**，说明人体抗病机能较亢奋，多属阳性病；**无热恶寒**，则阳气不足、机能沉衰的意味更重。
“七日愈、六日愈”只是古人对病程的概括，不能当成绝对日程。
本条实用点是：**不要只看恶寒两个字就判太阳病**，还要看有没有发热、脉象强弱、精神饮食等整体虚实。

李冠杰讲解

李冠杰老师讲第7条为**降两字格**，标三级。它不是太阳病主纲，而是说明发病阴阳属性与病程倾向。
“发热恶寒者，发于阳也；无热恶寒者，发于阴也”是本条核心。发热代表正气抗邪仍有力量，无热而恶寒则提示机能不足。
阳数七、阴数六可作传统解释了解，临床仍要抓**发热与否、恶寒性质、整体虚实**。



第8条

3 太阳病，头痛至七日以上自愈者，以行尽其经故也；若欲作再经者，针足阳明使经不传则愈。

词语解析

- **头痛至七日以上自愈**：说明有些太阳病随着正气恢复可以自解，**不是所有太阳病都必然传变**。
- **行尽其经**：按经脉运行解释病程，学习时可懂其意，**不可机械套时间**。
- **欲作再经**：病势似有继续转向的苗头，要观察是否出现**新的阳明、少阳或其它证候**。
- **针足阳明**：古人截断传经的一种思路，临床核心仍是**当前脉证是否转变**。

要点总结

第8条讨论太阳病**自愈与再传**。

再传判断：看是否出现**新的证候方向**。

临床重点仍是**看脉证，不按日数硬套**。

胡希恕讲解

胡希恕老师不会把第8条理解成太阳病一定七日传完。**头痛至七日以上自愈**，说明部分太阳病可随着正气恢复而自行解除。

“欲作再经”只是提示病势可能继续变化，要看有没有新的证候出现。

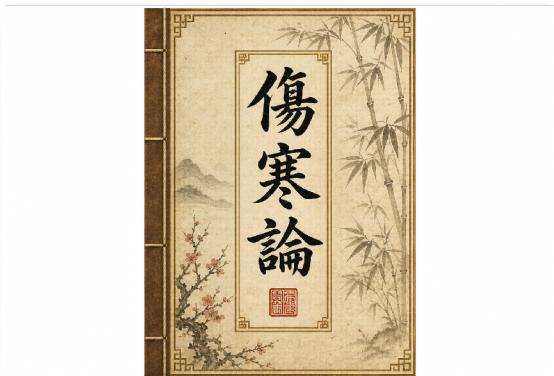
本条的临床意义是：轻证可观察，变化则随证处理；所谓针足阳明，也不能离开**当前脉证**。

李冠杰讲解

李冠杰老师讲第8条为**降两字格**，标三级，延续前面关于传经、病程的讨论。

“头痛至七日以上自愈”说明太阳病并非一定越来越重；“欲作再经”才提示要注意下一步变化。

学习时要防止把传经当固定程序，真正有用的是**观察病势，看证候是否转向**。



第9条

3 太阳病，欲解时，从巳至未上。

词语解析

- **欲解时**：指病势将要解除、症状有缓解趋势的时间段，不是固定处方依据。
- **巳至未上**：约上午九点到下午三点，阳气较盛，古人观察到太阳病较易**趋于缓解**。
- **如何判断欲解**：应看**恶寒减、脉转和、汗出得当、精神转佳**等实际变化。
- **临床看法**：时辰只作辅助参考，真正依据仍是**证候是否转解**。

要点总结

第9条讲太阳病欲解时。

判断欲解要看恶寒减、脉转和、精神转佳。

不可拘泥时辰，仍以实际脉证为准。

胡希恕讲解

胡希恕老师讲“欲解时”，多作病势观察参考，不把它当成决定治疗的核心。太阳病欲解从巳至未，是说阳气较盛时病势容易缓解。

但病是否真要解，仍要看**恶寒是否减轻、脉是否和缓、汗出是否得当、全身状态是否转佳**。

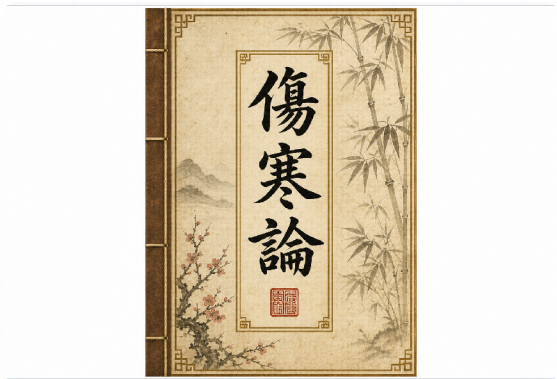
所以本条能帮助观察病程，却不能代替方证辨证。可靠的是**证候转和、病人自觉改善**。

李冠杰讲解

李冠杰老师讲第9条为**降两字格**，标三级。它是太阳病欲解时间的说明，不是主干方证条文。

“从巳至未上”大致是上午到下午阳气旺的时间段，古人借此说明太阳病有趋解的时机。

学习时可记其意，不必拘其时；要放在病势观察中用，**时辰只是辅助，脉证才是依据**。



第10条

3 风家表解，而不了了者，十二日愈。

词语解析

- **风家**：表虚经常容易感冒体质。
- **表解**：表证已经解除，恶寒发热等表证主矛盾不在，**不宜再强行解表**。
- **不了了**：表解后仍有轻微不爽、不清利、余证未尽，并非大病未解。
- **十二日愈**：提示恢复需要过程，轻微余证可待其自复，避免**过度发汗**、**过度攻伐**。

要点总结

第10条讲太阳中风表解后的恢复。

处理原则：余证轻微可观察，避免过治。

尤其要防止表已解而反复发汗。

胡希恕讲解

胡希恕老师讲“风家”，常联系太阳中风、表虚有汗一类。表解以后还有“不了了”，多是余邪未尽或正气未复，不一定需要再大发汗。

“十二日愈”提示病后恢复有过程。若表证已解，只剩轻微不爽，就要避免过度治疗，尤其不能把余证当成表邪未解而反复发汗。

本条精神是：**表解后看余证轻重，轻者可待其自复**。治疗不是越多越好，关键是不 要扰乱恢复。

李冠杰讲解

李冠杰老师讲第10条为**降两字格**，标三级，讲的是风家表解后的余证恢复。

“不了了”不是大病未解，而是表证已去、身体还没完全清爽。若误以为还要继续强发汗，反而可能伤津伤正。

学习本条要抓住：**表解以后，不要见一点不爽就继续攻表**。观察恢复过程，也是辨证的一部分。